

6-1. 배변이상(변비)

• 중요 포인트

- 1. 기질적 원인 (위장관폐쇄, 대사성, 신경성) vs. 기능적 원인 (식생활습관, 약물, 특발성 장운동 변화) 감별
- 2. 수분 섭취, 식습관, 운동 여부, 약제 사용
- 3. 교육: 생활습관 및 배변습관 교육, 변비약 장기복용 시 배변 반사신경 둔화로 인한 변비 악화 가능

• 평가 목표

원인				
기능성		기능성 변비, 약물 유발 변비, 과민대장증후군		
기질성		결장암/직장암, 갑상샘기능저하증, 신경 이상에 의한 변비, 직장류		
평가목표				
1) 추가 검사가 필요한 경우와 증상 치료만 해도 되는 경우를 구분 2) 추가 검사가 필요한 경우 원인 장기의 감별과 적절한 진단 및 치료 계획 수립				
구체적인 성과				
병력 청취	변비 양상(기간, 특징 등) 평가	기간: 만성 3 개월 변비의 특징 (변비의 정의를 만족하는지 확인): 딱딱한 변 / 변 볼 때 과도한 힘주기 / 항문이 막힌 느낌 / 잔변감 / 손가락으로 변을 긁어냄 기타 양상 평가: 배변양 / 변 굵기/ 색깔		
	기질적 원인에 의한 변비 감별	Obstruction: 종양, 협착 (염증성/허혈성 병변) 내분비: 갑상샘기능저하증 신경: 척수손상, 파킨슨병, 당뇨병으로 인한 자율신경병증 직장류 치핵, 치열		
	동반 증상과 위험 요인 평가	[동반증상] 과민대장증후군: 배변 후 복통 호전, 변비와 설사를 반복, 복부팽만 결장/직장암: 혈변, 체중감소, 피로 갑상샘기능저하증: 추위불내성, 피로, 체중증가(식욕감소) 항문질환: 항문 통증, 항문 덩이 정신과질환: 우울, 수면장애 [위험요인] 식습관, 배변습관, 스트레스, 운동, 술, 수분 섭취, 약제(아편제제, 철분제, 항고혈압제, 항콜린제) [Red flag sign -> 대장내시경 검사 필요] 1. 45 세 이상에서 배변 습관 변화 2. 위장관 출혈: 혈변, 흑색변, 철결핍성 빈혈 3. 체중감소 4. 대장암 가족력		
신체 진찰	원인 감별하기 위한 신체진찰	V/S 확인, 결막 확인(빈혈), 구강(탈수) 목: 갑상샘 촉진, 경부 림프절 촉진(암, 감염성 질환) 복부: 시, 청, 타(tympanic-장폐색), 촉(종괴 여부) DRE: 혈변, 종괴, 치핵 여부 확인		
진단 및 치료	원인 질환 감별	기능성	기능성 변비: X-ray, 대장통과시간, 항문압측정 과민성대장증후군: 대변검사, 혈액검사, 대장내시경	생활습관교정, 배변습관교정
		기질성	위장관폐쇄: 복부영상검사(CT, X-ray), 대장내시경, 혈액검사 대사성: 갑상샘기능검사 신경성: Spinal/Brain MRI 직장류: 배변조영술, 직장내시경	종양: 수술, 항암, 방사선치료 갑기저: 갑상샘호르몬 신경이상: 변비약 직장류: 케겔운동, 페서리, 수술

환자 교육	기능성 변비의 원인에 따른 조치	생활습관	식사: 규칙적인 식사, 섬유질/수분 섭취가 부족한 경우 대변의 양 자체가 감소하여 변비 유발 – 섬유질 많은 채소 섭취, 물 충분히 마시기 운동: 운동량 부족 시 변비 유발 – 하루 30 분 유산소 운동 금주/금연 스트레스 줄이기
		배변습관	변 볼 때 너무 힘주지 X, 화장실에 오래 앉아있지 X, 아침 식사 후 15~20 분 정도 변 보는 것에만 집중, 배변 시 뒤꿈치 드는 자세가 배변에 도움 변의가 있을 때 참고 무시하면 감각이 둔해져 변비 발생하므로 참지 않는 것이 좋음

● 원인 질환 정리

질환		병력청취	질환 설명	신체진찰	검사	치료
기능적 원인	기능성 변비 5+2	젊은 여자+평소 건강 섬유소, 수분 섭취 부족	검사상 특별한 이상은 없지만 대장의 기능이 떨어져 있는 상태	[DRE] 항문열상	X-ray, 대장통과시간, 항문압측정	섬유소, 수분 섭취 증가 규칙적 식사, 적절한 운동 배변습관 교정
	과민대장 증후군(IB S)	복통 – 배변 후 복통 호전 복부팽만, 변비-설사 반복, 점액질 변, 소화불량, 방귀트림	검사상 특별한 이상은 없지만 식사나 가벼운 스트레스 후 복통, 복부 팽만, 변비, 설사 같은 소화기 증상이 반복되는 질환	경미한 복통 (배변 후 호전)	대변검사, 혈액검사, 대장내시경	심리적 안정 스트레스 줄이기 식습관 교정 적당한 운동
	약물 유발 변비	Hx. 아편제제, 철분제, 항콜린제, 항고혈압제				약물 중단
기질적 원인	결장암/ 직장암	[전신] 체중감소, 피로 [소화기] 혈변, 대변 가늘어짐	대장(결장/직장)에 생긴 종양에 의해 변이 나오는 통로가 막힘	[DRE] 종괴, 혈변	대장내시경, CT	수술, 항암, 방사선치료
	갑상샘기 능저하증	추위불내성, 피로, 체중증가(식욕 감소), 피부 푸석	갑상샘이 갑상샘호르몬을 충분히 만들지 못함	갑상샘 종대	갑상샘기능검사	갑상샘호르몬
	신경 이상 에 의한 변비	Hx. 척수손상/치매/ 파킨슨병/당뇨 병으로 인한 자율신경병증	장의 움직임이 신경에 의해 조절되어야 하는데 신경 이상으로 인해 잘 조절되지 못함	신경학적 이상소견 (+)	Spinal/Brain MRI	변비약
	직장류 1+1	여성 – 출산/고령 잔변감, 질 쪽으로 밀려나오는 느낌	약해진 직장 벽이 질 쪽으로 늘어나서 볼록하게 튀어나오는 것	골반내진 상 힘 쫓을 때 질 쪽으로 덩이가 내려옴	배변조영술, 직장내시경	케겔운동, 패서리, 수술

O	언제부터 갑자기/계속		cf. 급성(<3mo): 종양, 협착 등 기질적 원인 가능성, 최근 발생한 배변습관 변화, 약물 만성(>3mo): 식이섬유/수분 부족, 위장관 신경계 이상, 정신질환, 약물
L	-		
D	일주일에 변 몇 번 변비: 주 3 회 미만 or 배변량 < 25~200mg/일 변 볼 때마다 변비인지 (+설사가 나올 때도 있나요? IBS)		
Co	심해지나요?		
Ex	이전-> 변비약 복용? 얼마나 오래? 효과?		
C	[양상] 굵기 / 딱딱 / 색 [힘손막잔] 변 볼 때 과도한 힘 / 손가락으로 변 긁어냄 / 항문이 막힌 느낌 / 변이 남은 느낌 (잔변감) [OPEN] 평소 변 볼 때 습관은 어떠신가요? ; 오래 앉아있나요 / 화장실에서 핸드폰, 신문 / 오래 참는지 / 집에서만 화장실 가는지 [일상] 일상생활 지장 [많이 힘드셨겠어요]		
A	[OPEN] 다른 불편한 곳은 없으세요?		
	전신	피로/체중변화(증가/감소) r/o 암	
	소화기	식욕저하/구역,구토/설사/흑색변,혈변 복통(양상, 배변 후 호전)/복부팽만 r/o IBS	
	항문	항문통증/항문덩이. r/o 치핵, 치열	
	직장류	질 쪽으로 밀려나오는 느낌	
	갑상샘	추위불내성, 피부 푸석	
	정신	우울/수면장애	
F	악화/완화 요인 : 스트레스, 식사와의 관련성 - IBS		
E	건강검진+위내시경/대장내시경		
외	복부/항문/척추 수술 외상		
과	HTN/DM/결핵/간 소화기질환 당뇨 조절		
약	약물 (아편제제/철분제/항콜린제/항고혈압제)마약성진통제/철분제/콧물, 기침, 알레르기약/고혈압약		
사	술/담배/커피/직업/식습관(자극적인 음식, 식이섬유/채소, 물)/운동/스트레스		
가	대장암/변비		
여	규칙적/LMP/주기와의 관련성/임신가능성		
PEx	동의 구하기 손 씻기		
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈 2 입: 탈수 3 목: 갑상샘 촉진, 경부 림프절 r/o 암 4 사지 : 피부 긴장도, 오목부종	
	복부	복부: 시(외상/수술 흔적, 팽만)-청 (1 군데 당 3-5 초)-타 (먼 곳부터)-촉(먼 곳부터) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기	
	DRE	안내	손씻기+환자 확인 변비의 원인을 알아보기 위해 항문직장검사 시행하겠습니다 항문에 손가락 넣어서 항문, 직장의 종양, 혈변 (+전립선) 확인하기 위한 검사 불편함

	자세	나 등지고 누워+원다리는 그냥 피고+오른다리는 가슴에 붙도록 90 도 구부리고 새우등 자세+엉덩이는 최대한 뒤로 빼서 새우등자세	
	PPI	옷 내리세요+불필요한 부분은 가려드리겠습니다 안보여서 불안하겠지만 모든 과정 말로 설명하고 진행할테니 걱정 안하셔도 됩니다	
	시진	항문주변- 덩이 셋길 궤양 염증 없음+변보듯 힘주세요	
	촉진	항문주위 만져볼게요-덩이/압통	
	손가락	손가락 넣어 진찰할 것- 젤 차갑고 불편함 => 변참을때처럼 힘주고 힘빼기 빨 때 빼겠습니다 하기+끝났습니다 고생많으셨습니다+여분 휴지	
	마무리	변색성상+ 병변: 항문직장선 기준 *cm 상방+*cm 크기+*시 방향 등근모양+매끄러움/울퉁불퉁경계+고정/유동+압통	
	골반내진	직장류 의심시 검사 필요성 및 방법 설명하고 동의 구하기, 성경험 확인	
협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기			
	기본!! (기질성 vs 기능성 감별)	복부영상검사 혈액검사 대장내시경 대장항문기능검사	생활습관교정, 배변습관교정 필요시 변비약 기질적 원인은 원인질환에 따라 치료
	갑상샘기능저하 증	갑상샘기능검사	갑상샘호르몬
	결장/직장암	대장내시경 복부 CT	검사 후 병기에 따른 치료 – 수술/항암/방사선
	직장류	배변조영술 직장내시경	케겔운동, 페서리, 수술
교육	[그동안 변비 때문에 많이 고생하셨을 것 같습니다. 지금부터 치료를 잘 받으시면 호전되실 수 있습니다. 일찍 병원에 잘 오셨습니다.] [안심시키기(기능성변비)] 변비는 기질적인 원인이 없는 경우가 90%. 대부분 생활습관 개선으로 호전될 수 있다. [합병증] 치료하지 않으면 치질, 치열 등 항문질환이 생길 수 있음 [생활습관 개선] 식사: 규칙적인 식사, 섬유질 많은 채소 섭취, 물 충분히 마시기 운동: 하루 30 분 유산소 운동 금주/금연 스트레스 줄이기 [배변습관 개선] 변 볼 때 너무 힘주지 X, 화장실에 오래 앉아있지 X, 아침 식사 후 15~20 분 정도 변 보는 것에만 집중, 배변 시 뒤꿈치 드는 자세가 배변에 도움 변의가 있을 때 참고 무시하면 감각이 둔해져 변비 발생하므로 참지 않는 것이 좋음 [변비약 위험성] 정확한 진단 전까지 변비약 사용 주의. 너무 많이 복용하면 오히려 이차성 변비 생길 수 있으므로 증상이 심할 때만 짧게 복용 [국가암검진] 대장암은 만 50 세 이상 남녀 대상 매년 분변 잠혈검사를 시행 (이상 시 대장내시경 검사)		
PPI	궁금하신 점 있으실까요?		